

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO  
NOMOR : 108.7/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2025

TENTANG  
PENEMPATAN STAF KLINIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keselarasan antara kebutuhan staf di bidang pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal maka diperlukan pengaturan penempatan staf klinis di Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tentang penempatan staf klinis.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 001.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 038/DPM/I-KEP/DIR/II/2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Periode 2023-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO  
TENTANG PENEMPATAN STAF KLINIS
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 25 Januari 2025 menempatkan **Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz** sebagai **Ahli Gizi Unit Hemodialisa**
- Kedua : Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pasuruan  
Pada Tanggal 25 Januari 2025  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



**dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA  
HUSADA SUKOREJO  
NOMOR 108.7/RSPHS/I-KEP/DIR/II/2025  
TENTANG PENEMPATAN STAF KLINIS

**A. Kualifikasi**

1. Kualifikasi
  - Ahli Gizi
2. Pendidikan
  - DIII/S1 Gizi
  - STR dan SIP aktif
3. Kompetensi
  - Sertifikasi Hazzard

**B. Uraian Tugas**

1. Melakukan penilaian status gizi pasien hemodialisa secara menyeluruh:
2. Mengumpulkan data antropometri (BB, TB, IMT, lingkar lengan, dll).
3. Pemeriksaan biokimia (albumin, kadar ureum, kreatinin, elektrolit, dll).
4. Data klinis (riwayat penyakit, gejala, komplikasi, tekanan darah, edema).
5. Riwayat diet (kebiasaan makan, asupan harian, pantangan, dll).
6. Menilai tingkat malnutrisi menggunakan tools seperti SGA (Subjective Global Assessment) atau MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
7. Menyusun rencana diet individual berdasarkan hasil asesmen:
8. Menentukan kebutuhan energi, protein, cairan, natrium, kalium, fosfor, dan zat gizi lain sesuai kondisi pasien.
9. Menyesuaikan diet sesuai frekuensi dialisis dan komplikasi (misalnya anemia, hipertensi, gangguan elektrolit).
10. Menyusun diet rendah garam, rendah kalium, rendah fosfor, tinggi protein, dan pengaturan cairan sesuai indikasi.
11. Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga:
12. Memberikan pemahaman tentang pengaturan diet untuk pasien hemodialisa.
13. Menyusun materi edukasi dalam bentuk leaflet, poster, atau konsultasi langsung.
14. Memberikan saran alternatif makanan lokal yang sesuai diet.
15. Memberikan edukasi cara membaca label makanan dan membatasi makanan olahan.
16. Melakukan pemantauan terhadap:
17. Perubahan status gizi pasien secara berkala (bulanan/triwulanan).
18. Kepatuhan diet dan perubahan asupan makanan.
19. Pemeriksaan lab lanjutan (albumin serum, kadar elektrolit, dll).
20. Evaluasi efektivitas intervensi dan modifikasi rencana gizi bila perlu.
21. Berkoordinasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain:
22. Terlibat dalam diskusi kasus atau rapat tim medis.
23. Memberi masukan mengenai status gizi dan rekomendasi diet.
24. Mendukung pengambilan keputusan klinis terkait perawatan pasien.
25. Mencatat semua hasil asesmen, rencana intervensi, edukasi, dan evaluasi dalam rekam medis.
26. Menyusun laporan gizi pasien secara berkala untuk unit hemodialisa.
27. Melakukan input data untuk pelaporan mutu gizi (seperti angka kejadian malnutrisi pada pasien HD).
28. Mengikuti pelatihan atau seminar tentang gizi pasien penyakit ginjal.
29. Melakukan penelitian sederhana terkait gizi dan hasil klinis pasien HD.
30. Mengembangkan SOP gizi untuk unit HD sesuai standar rumah sakit.

**C. Tanggung Jawab**

1. Melakukan penilaian status gizi pasien (misalnya menggunakan antropometri, laboratorium, dan riwayat diet).
2. Mengidentifikasi risiko malnutrisi dan status hidrasi (terlalu banyak atau terlalu sedikit cairan).
3. Memantau perubahan status gizi secara berkala (biasanya setiap bulan atau minimal 3 bulan sekali).
4. Menyusun rencana diet berdasarkan:
5. Status gizi
6. Fungsi ginjal residu

7. Parameter laboratorium (K, P, Na, albumin, urea, kreatinin)
8. Kondisi klinis pasien (misalnya diabetes, hipertensi)
9. Preferensi makanan pasien
10. Mengatur asupan protein, cairan, natrium, kalium, dan fosfor secara tepat.
11. Menentukan kebutuhan energi dan mikronutrien.
12. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai:
13. Diet rendah garam, kalium, dan fosfor
14. Pengaturan cairan
15. Pemilihan makanan sehari-hari
16. Penggunaan suplemen atau pengganti makanan jika diperlukan
17. Edukasi dilakukan secara individu atau kelompok.
18. Menilai kepatuhan pasien terhadap diet.
19. Memantau hasil laboratorium dan menyesuaikan intervensi diet.
20. Bekerja sama dengan tim medis (dokter, perawat, apoteker) untuk pengambilan keputusan berbasis gizi.
21. Berkolaborasi dalam tim perawatan dialisis untuk penanganan pasien secara holistik.
22. Memberikan masukan tentang asupan nutrisi sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan terapi hemodialisa.
23. Mencatat semua hasil asesmen, intervensi, edukasi, dan pemantauan dalam rekam medis pasien sesuai standar pelayanan.

#### **D. Wewenang**

1. Melakukan penilaian status gizi pasien hemodialisis secara berkala (menggunakan antropometri, data biokimia, riwayat diet, dan status klinis).
2. Menilai risiko malnutrisi dan kekurangan zat gizi.
3. Menyusun rencana makan individual berdasarkan kebutuhan pasien (kalori, protein, cairan, natrium, kalium, fosfor, dll).
4. Merancang menu khusus untuk pasien dengan pembatasan tertentu sesuai hasil asesmen gizi.
5. Memberikan edukasi dan konseling gizi kepada pasien dan keluarga tentang diet khusus pasien hemodialisis.
6. Menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap diet untuk mencegah komplikasi seperti hiperfosfatemia, hiperkalemia, dan kelebihan cairan.
7. Memantau perkembangan status gizi dan kepatuhan terhadap diet pasien secara berkala.
8. Mengevaluasi hasil intervensi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9. Bekerja sama dengan dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan pasien.
10. Memberikan masukan dalam rapat tim tentang masalah gizi pasien.
11. Menyusun dan meninjau standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan gizi pasien hemodialisis.
12. Terlibat dalam kegiatan audit gizi, penelitian, atau evaluasi mutu layanan gizi di unit hemodialisa.

Ditetapkan Di Pasuruan  
Pada Tanggal 25 Januari 2025  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



**dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS**